

## La salud infantil en un municipio de 10.000 habitantes

### Prof. Dr. Juan Alberto Reichenbach

Doctor en Medicina. Profesor adjunto Cátedra de Pediatría B de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP. Especialista consultor en Pediatría. Autor de *Pediatría en Red*.

### Una historia como la de tant@s

Camila terminó su residencia de Pediatría en un reconocido y prestigioso hospital de derivación nacional de una ciudad universitaria.

El año de su graduación de médica, egresaron de las facultades nacionales aproximadamente 6000 médicos, como todos los años. 12 años de formación. 7 para obtener el título de grado, 4 años de residente y 1 de jefa de residentes. Casi exclusivamente entre los muros de hospitales de reconocido prestigio, a pesar de los programas de grado y postgrado que abundan en semántica acerca de la estrategia de Atención Primaria de la Salud.

De los 6000 egresados, solo el 10% trabajará en servicios hospitalarios. Muchos harán una especialidad y aun en las ciudades trabajarán de clínicos pediatras. Hiperespecialidades por la mañana en un servicio hospitalario complejo, consultorio de atención clínica por las tardes.

Hay 1 médico cada 100 habitantes en las grandes urbes. 1 cada 1000 en el país interior. Menos enfermeros que médicos. Pocos obstetras.

Aproximadamente el 15% de los 6000 egresados optan por la pediatría y sus especialidades afines.

La Medicina infantil ya es un compendio interminable de especialidades, quizás impuestas por el mercado. Se diluye la función esencial del clínico pediatra.

En las facultades y en las residencias, las competencias adquiridas priorizan las afecciones infrecuentes, las formas infrecuentes de afecciones frecuentes y la reparación. El dominio de la enfermedad por sobre la salud.

Las currículas “ocultas” dictadas por el hecho asistencial cotidiano de hospitales reparan lo evitable. Excelente formación en las bronquiolitis internadas (3% del total), en las neumonías complicadas, en las meningitis decapitadas, en el quemado grave evitable, en el prematuro extremo sin controles maternos.

“Hospitales llenos marcan el fracaso de la salud pública”, decía Ramón Carrillo.

Camila optó con su pareja, también pediatra, por radicarse en ese partido de la depresión del Salado, distante 100 km de la ciudad de La Plata, con un Sistema Municipal de Salud organizado, con una comunidad que participa, con acceso universal y nominalización de la población, en red con los centros asistenciales de la ciudad universitaria y con un excelente sistema de traslado.

Su nuevo perfil profesional debe gestionar, asistir y planificar la salud de los niños de ese municipio de 10.000 habitantes, con 3400 menores de 20 años.

O sea, 2 pediatras “full time” que trabajan con población a cargo nominalizada. Un cálculo inicial, calculando un promedio de 4 consultas por cada uno

por año, acerca a las 12.000 consultas anuales, 1000 consultas por mes y 500 por pediatra por mes.

### **Las competencias necesarias**

**¿Seré la pediatra que necesita esta comunidad?, se pregunta la noche de insomnio previa al arribo a la localidad.**

**¿Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué capacitarse en esta nueva aventura?**

“Los ejes son la clínica, la historia clínica, la relación médico-paciente, el análisis de problemas y evidencias, el análisis de los perfiles epidemiológicos y las prioridades sociales”.

“Hay que orientar los programas a problemas comunitarios, a los problemas prevalentes y hacia los problemas regionales”, dice el Programa de Salud “Indio Sano, una construcción comunitaria de la salud” del municipio.

¿Cómo será este municipio rural de la pampa deprimida del Salado?

**Ahora debo gestionar, asistir y planificar la salud materno-infantil del municipio. O sea, la salud integral, con las familias.**

Pensaba en la demanda en los CAPS municipales. En los 30 turnos totales pactados por mañana, uno cada media hora, el 60% de los que asistan tendrán menos de 20 años (18).

¡Lástima que cursé solo 2 meses Pediatría en el grado y que en los 4 años de la residencia estuve solo dos meses en una unidad sanitaria urbana! Los consultorios hospitalarios no representan la epidemiología de estos escenarios alejados.

El apunte decía que debo confeccionar una tabla de prioridades sociales y averiguar acerca del perfil epidemiológico de la comarca.

### **Torbellino de preguntas**

**Aparecen desordenadas, espero que el tiempo, la experiencia y el estudio en terreno le pongan la necesaria lógica y el deseado orden.**

¿Cuáles serán las 10 causas más frecuentes de consulta en salud en la infancia?

¿Habrá programa de salud escolar?

¿Cómo hago para planificar la educación comunitaria? Los Consejos Vecinales de Salud y el Programa de Salud del Municipio lo tienen desarrollado hace años.

¿Quién me facilitará el diagnóstico inicial de salud materno-infantil?

¿Las embarazadas están nominalizadas?

¿Hay un equipo de salud organizado?

¿Hay un sistema de atención por cuidados progresivos?

¿Cuántos menores de 20 años habitan el partido?

¿Cómo están distribuidos según grupos de edad?

¿Cuántos recién nacidos hay por año en el municipio?

¿Cuál es la Tasa de Mortalidad Infantil de la zona?

¿En qué momento de su vida se mueren?

¿Se mueren uniformemente en las diferentes áreas del municipio? ¿Por qué?  
 ¿Qué porcentaje de recién nacidos prematuros hay en la región?  
 ¿Y de recién nacidos de bajo peso al nacer?  
 ¿Qué razón de mortalidad materna hay en la zona?  
 ¿Cuántas madres son menores de 20 años?  
 ¿Cuántas madres son analfabetas?  
 ¿Cuántos abortos se estiman por año?  
 ¿Se realiza control adecuado del embarazo?  
 ¿Hay Maternidades con Condiciones Obstétricas Neonatales Esenciales (CONE)?  
 ¿Hay unidades de cuidados intensivos neonatales adecuadas?  
 ¿Hay Centros de Atención Primaria (CAPS) integrados en el Sistema Municipal?  
 ¿Se desarrolla la estrategia de Atención Primaria de la Salud (APS)?  
 ¿Hay participación comunitaria en las acciones de salud, desarrollo social y educación?  
 ¿Hay articulación interdisciplinaria?  
 ¿Hay articulación intersectorial?  
 ¿Hay desarrollo de programas de escuelas para la salud?  
 ¿Hay acceso de toda la población?  
 ¿Hay referencia, contrarreferencia e historia única de salud en el área ambulatoria y hospitalaria?  
 ¿Hay ligas comunitarias de lactancia materna?  
 ¿Hay un proyecto de Promoción y Extensión de la Lactancia Materna?  
 ¿Está toda la población vacunada adecuadamente?  
 ¿Cuáles serán los problemas prevalentes y sus escenarios de atención?  
 ¿Cuáles serán las consultas frecuentes?

En el teórico se afirmaba que 20 motivos de consulta explican el 82% de los problemas de enfermedad en el niño.

¿Cuáles serán las consultas frecuentes en la Emergencia, en la sala, en la Maternidad, en el Consultorio Externo?

Camila trajo el libro *Pediatría en Red* con 100 situaciones problemas en el área asistencial, pero con su forma de comienzo habitual, desde los signos y síntomas guiones.

¿Cuáles serán las causas de morbimortalidad general en el municipio?  
 ¿Tendrá el municipio una red para la derivación de las situaciones que requieran internación?  
 ¿Cómo era eso del niño sujeto de derecho?  
 ¿Y el proceso clínico centrado en la persona?  
 ¿La salud escolar?  
 ¿El niño que trabaja?  
 ¿Las discapacidades?  
 ¿La prevención cuaternaria?  
 ¿La violencia desde el nacimiento? ¿El niño en situación de calle?  
 ¿Los controles promedio de los lactantes y los niños hasta la edad escolar son los necesarios? ¿Hay guarderías?  
 ¿Hay programas de alimentación saludable en las escuelas?

¿El pueblo tiene plazas, club, centros recreativos y deportivos?  
 ¿El medio ambiente es saludable? ¿Hay recolección adecuada de la basura?  
 ¿Hay mataderos o frigoríficos? ¿Hay control bromatológico en la comunidad?  
 ¿Toda la población tiene agua potable y cloacas?  
 ¿El aire está contaminado?  
 ¿Las aguas están contaminadas?  
 ¿Las tierras padecen organofosforados o glicerosfosfatos?  
 ¿Hay cianuros en la zona? ¿Arsenicismo? ¿Plomo?  
 ¿Hay colilargos en la zona? ¿Leptospirosis? ¿Hay vinchucas infectadas? ¿Ofidismo, alacranes?  
 ¿Es zona de tránsito del dengue? ¿Larvas *migrans visceralis*? ¿Casos de gripe porcina en las últimas epidemias? ¿Botulismo?  
 ¿Ganado ovino, caprino? ¿Hidatidosis? ¿Fiebre hemorrágica, brucelosis?  
 ¿Hay poblaciones golondrina? ¿Tuberculosis? ¿Enfermedades de transmisión sexual?  
 ¿Casos de HIV?  
 ¿Hay pueblos originarios?  
 ¿Adicciones?  
 ¿Rutas cercanas?  
 ¿Cuáles son las condiciones habitacionales del pueblo? ¿Hay planificación urbanística?  
 ¿Cómo es el clima de la zona?  
 ¿Hay catástrofes naturales habitualmente? ¿Inundaciones?  
 ¿El agua es segura? ¿Hay programas de alimentación saludable?  
 ¿Las familias tienen trabajo adecuado?  
 ¿Hay alumnos repitentes y abandono escolar pronunciado?  
 ¿Es una comunidad multiétnica?  
 ¿Los niños y las niñas trabajan? ¿Los adolescentes trabajan o estudian?  
 ¿Toda la población, incluida la infantil, está nominada?  
 ¿Hay incidencia elevada de suicidios?  
 ¿Hay violencia de género?  
 ¿Hay niños en situación de calle?  
 ¿Qué porcentaje de la población infantil tiene discapacidad?  
 ¿Hay detección de niños con trastornos del espectro autista?  
 ¿Hay articulación municipal de los programas verticales de Provincia y Nación?  
 ¿El Sistema Municipal de Salud tiene un vademécum propio?  
 ¿Hay relación entre los efectores del primer nivel de atención y los de máxima complejidad?  
 ¿Hay sistema planificado de derivación?  
 ¿Cómo era eso de la visión ampliada y la extensión de la salud infantil?  
 ¿El Sistema Municipal de Salud tiene ordenanza de regulación?  
 ¿Qué porcentaje del presupuesto se utiliza en acciones de APS?  
 ¿El Sistema Municipal de Salud tiene carrera de salud municipal?  
 ¿El capital humano es el adecuado? ¿Son *full time*?  
 ¿El Sistema Municipal articula con el subsector privado y el de las obras sociales?  
 ¿Hay participación comunitaria organizada en el Concejo Deliberante en lo que concierne a Desarrollo Social, Salud, Trabajo y Educación?  
 ¿Hay control social de la consecución de las Metas en Salud?  
 ¿Se han evaluado las prioridades sociales en salud?  
 ¿Se ha evaluado el perfil epidemiológico regional?

¿Hay formas de Educación Permanente en Salud?

¿Hay medios de comunicación locales?

¿Cómo era aquello de que el pediatra debe ejercer funciones de abogacía, conceptualizando al niño como sujeto de derecho?

¿Cómo se cumplen los derechos del niño?

¿Dónde se deben cumplir? ¿Qué dice la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)?

¿Cuáles son los derechos del niño?

¿Quiénes son los responsables del cumplimiento de esos derechos?

¿Cuáles son los instrumentos legales para su cumplimiento?

¿Cuáles son las necesidades elementales de los niños?

¿Cuáles son los 10 principios de la Convención de los Derechos del Niño?

¿Cuál es el diagnóstico de situación en la comarca?

¿Hay delegación regional de la CONAETI para evaluar el trabajo infantil?

¿Hay juzgado de paz?

¿Registros de abusos sexuales, incesto, maltratos en la infancia del lugar?

¿Seguridad peatonal?

¿Y el pequeño Hospital de la Comunidad?

¿Qué servicios brinda en la Emergencia, en la sala, en la Maternidad, en el Consultorio Externo?

#### **Primera pregunta: ¿Cuántos son?**

Se calcula que la población menor de 20 años es el 33,26% del total de la población (DEIS. Ministerio de Salud de la Nación. 2010) en nuestro país.

Proyectaremos ese escenario país al distrito comprendiendo sus singularidades, solo para aproximarnos.

Habría entonces 3326 menores de 20 años, distribuidos aproximadamente en un 25% por cada uno de estos quintiles de la siguiente manera.

Distribución de la población menor de 20 años(n 3400)

|             |      |
|-------------|------|
| 0 a 5 años  | 850. |
| 5 a 10 años | 850. |
| 10 a 15     | 850  |
| 15 a 20     | 850. |

#### **DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTO JUVENIL SEGÚN GRUPOS DE EDAD. ARGENTINA. 2011.**

| QUINTIL | n         |
|---------|-----------|
| 0 A 4   | 3.428.566 |
| 5 A 9   | 3.329.368 |
| 10 A 14 | 3.395.834 |
| 15 A 19 | 3.450.509 |

Esto será importante para calcular, más adelante, el número de consultas anuales de Camila, sus horas de trabajo y su sueldo, en el marco del Presupuesto Participativo en Salud.

## **Nacimientos**

Se calcula un 2,5% de nacimientos cada 10.000 personas por año  
*Moreno, Irma y col. Guía de Programación Local. Ministerio de Salud de la Nación 2000.*

250 por año, aunque en esta región los jóvenes emigran, de allí que la cifra estimada varíe entre 150 y 200 por año.

En el municipio, los Consejos Vecinales de Salud y la facultad de Humanidades de la UNLP habían realizado una **tabla de prioridades sociales**.

Les interesaba saber qué opinaba la GENTE de la salud en sus municipios.

## **¿Qué preocupa a la gente en salud materno-infantil? (medio rural)**

### **TABLA DE PRIORIDADES SOCIALES**

Indio Sano. 1996. 11.200 habitantes. Dirección de Política Social y Salud.

*Colabianchi L, Reichenbach J. Indio Sano. Una Construcción Comunitaria de la Salud. Buenos Aires. Del Sur; 1997.*

- 1 Alcoholismo.
- 2 Dificultad de acceso a centros de atención de la salud.
3. Falta de trabajo.
4. Embarazo en adolescentes.
5. Bajos salarios.
6. Falta de viviendas.
7. Incremento de accidentes en la ruta.
8. Insatisfacción con el Sistema de Salud.
9. Alta proporción de problemas de salud en los ancianos.
10. Carencia de agua potable y cloacas.

## **¿Qué preocupa a la gente en salud materno-infantil? (medio urbano)**

*García Azzarini L, Reichenbach J. La Planificación Estratégica de la Salud por Juntas Vecinales de La Plata: AIEPI OPS; 2004.*

1. Grupos sociales en riesgo y exclusión.
2. Vínculos familiares sin vivencias placenteras.
3. Embarazos adolescentes y familias numerosas.
4. Violencia familiar y maltrato infantil.
5. Crisis familiar y ausencia de valores.
6. Preparación médica insuficiente en la problemática social.
7. Consumo de drogas.

## **¿De qué se enferman nuestros niños? Motivos espontáneos de consulta al CAPS**

En este caso se usaron dos estudios en escenarios distintos, pero con resultados sorprendentemente semejantes.

**PERFIL EPIDEMIOLÓGICO.  
(EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA).  
10 MÁS FRECUENTES.**

| MOTIVOS DE CONSULTA                     | N° TOTAL                  | INTERNACIONES      |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Infecciones respiratorias altas y bajas | 3.645 (303 Bronquiolitis) | 10                 |
| Diarreas                                | 603                       | 4                  |
| Bronquitis Obstructivas. Asma.          | 520                       | 5                  |
| Control del Crecimiento y el desarrollo | 706                       | 0                  |
| Neumonías                               | 122                       | 2                  |
| Enfermedades infectocontagiosas         | 421                       |                    |
| Parasitosis                             | 443                       |                    |
| Afecciones de piel                      | 340                       |                    |
| Infecciones urinarias                   | 83                        | 1                  |
| Otros síntomas agrupados                | 200                       | 5 abdomenes agudos |

Dr. Reichenbach Juan, "Indio Sano. Una construcción Comunitaria de la Salud". Editorial del Sur. 1997

**Comentario:** Cuando se trata de ASISTIR la demanda en un CAPS, 10 motivos explican casi el 83 % de la consulta. La mayoría de las situaciones NO requieren internación. La totalidad pueden prevenirse y promoverse en la comunidad, con un equipo de salud y la comunidad participando. Un pediatra de comunidades pequeñas tendrá que utilizar la clínica pediátrica como herramienta fundamental. Deberá reflexionar, con la herramienta de la comunicación y la experiencia semiológica. Deberá diagnosticar oportunamente y derivar adecuadamente, con una red armada de progresión creciente. No olvidemos que solo el 10% del total trabajará en un Hospital de Máxima Complejidad. No olvidemos que de las patologías prevalentes en Pediatría un INFIMO número requieren internación.

El cuadro anterior es inicial para imaginar los 40 años de Camila como pediatra en esa comunidad. DEFINE ALGUNAS DE LAS COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO EN LOS MUNICIPIOS DE NUESTRO PAÍS.

En el mismo año lo hicimos en nuestro hospital de formación.

**Perfiles epidemiológicos en pediatría**

Reichenbach, Juan y col. *Criterios Diagnósticos en Clínica Pediátrica. Pediatría en Problemas.* Tomo IV. 1997.

Consultorio Externo del Hospital de Niños "Sor María Ludovica" de La Plata (año 1997. 75.000 consultas en el año).

1. Infecciones respiratorias altas 36%.
2. Diarreas 9%.

3. Bronquitis obstructivas .Asma 8%.
  4. Control del crecimiento y el desarrollo 7%.
  5. Neumonías 5%.
  6. Enfermedades infectocontagiosas 5%.
  7. Parasitosis 4%.
  8. Afecciones de piel 4%.
  9. Infecciones urinarias 3%.
  10. Otros síntomas agrupados 2%.
- Total 83% de la consulta.

10 motivos de consulta explican el 83% de la demanda espontánea. **La casi totalidad no requiere internación.**

### **¿Qué problemas de salud encontraron en las escuelas del distrito?**

En 12 años de formación no entré a ninguna escuela, piensa Camila.

El Consejo Escolar del Distrito y los Consejos Locales de Salud articularon y bajaron el Programa Nacional de Salud Escolar con regulación del Estado Municipal.

Tengo estetoscopio, 5 mangos para tomar la tensión arterial, un optotipo regalado, una balanza, un barral de madera para la talla, las tablas de Cuminsky y las de la OMS, el PRUNAP, un calendario de vacunaciones, las vacunas y los tests para descartar TEA.

¡Nunca fui a una escuela!

Roté por Quemados, Cirugía Cardiovascular, Terapia Intensiva, Terapia Intermedia, Niño Sano, Emergencias, Maternidad, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Inmunodeprimidos y Oncología en Barcelona, pero... nunca por una escuela.

### **El Informe del Consejo de Salud de Punta Indio.**

**Los problemas de salud escolar fueron los siguientes:**

De 1497 alumnos revisados, 766 (51,16%) presentaban alteración funcional o patológica.

Me llama la atención que haya pocos obesos, piensa Camila.

¿Qué hago con los niños con soplos funcionales? Los controlo en 1 mes.

Cuando sospecho patología orgánica, los derivo a la Red de Hospitales pediátricos de la Región Sanitaria XI que tiene convenio con el Municipio.

Les mando una historia (la municipal) y les solicito la contrarreferencia y los turnos de seguimiento. Les solicito precisiones diagnósticas, seguimiento y bibliografía.

**Para la Educación Permanente consulto el Pronap y el Portal de Educación Permanente en Pediatría**



## PROBLEMA 7.

GESTIONAR, ASISTIR Y PLANIFICAR LA SALUD  
DE LOS NIÑOS DE UN BARRIO, PUEBLO O MUNICIPIO.

| PROBLEMAS                       | N° DE ALUMNOS: 1402 | % DEL TOTAL |
|---------------------------------|---------------------|-------------|
| Caries dentales                 | 282                 | 20          |
| Déficit visual                  | 218                 | 16          |
| Obesidad                        | 119                 | 8           |
| Hipertensión arterial           | 92                  | 6           |
| Soplo cardíaco (55 funcionales) | 61                  | 4           |
| Afecciones dermatológicas       | 37                  | 2,4         |
| Cifoescoliosis                  | 29                  | 2           |
| Ortodoncia                      | 22                  | 1,5         |
| Distrofia de primer grado       | 8                   |             |
| Talla baja                      | 7                   |             |
| Mal oclusión                    | 7                   |             |

1.

**Comentario:** Un Médico general en una comunidad atenderá el 65% de su consulta entre menores de 20 años y mayores de 60. Sus acciones serán de gestión, control de salud, promoción, prevención y extensión comunitaria, con fuerte interacción con distintos sectores, ONGs, comunidades y con todo el equipo de salud. El pediatra debe tener esta reflexión inicial. Desde la Residencia, desde la Carrera pretendemos sellar esta impronta, que definirá la función social de esta profesión en el territorio donde desarrolle su actividad.

**Comentario:** Un adecuado control del embarazo y una oportuna y adecuada derivación evitaría en un alto porcentaje y de bajo peso. Las anomalías congénitas deberían ser anticipadas y derivadas oportunamente, luego de un adecuado

El Programa de Residencias de Camila incluía la salud escolar.

## Acerca de la Clínica Pediátrica

### En Programa de Residencias de Clínica Pediátrica de 4 años.

“La Clínica Pediátrica abarca todos los escenarios de la atención de un niño, desde el consultorio a la terapia, pasando por la escuela del barrio. Los niños no deberían atenderse en sectores estancos. Su esencia, para el médico responsable, es la misma, aunque cambie el lugar de atención. Su herramienta es la Clínica, tan confundida y menospreciada en los siglos de las radiaciones y las ‘últimas generaciones’.

Debe resurgir no como un híbrido de ocasión, sino con sus rasgos humanitarios y artesanales, con la calidad y la excelencia, pero al servicio del bienestar de nuestro futuro hecho niños...” (En: *Portal de Educación Permanente en Pediatría. Subsecretaría de planificación de la Salud. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires; 2011*).

A las 9:00 h de la mañana siguiente, recibiría al primer recién nacido de su nuevo distrito en el Hospital Municipal.

Una serie interminable de preguntas la acosaron.

Se calcula que una población de 10.000 habitantes tiene un 2,5% de nacimientos de su población total por año. 250 nacimientos por año promedio en poblaciones con muchos jóvenes. Claro que esta comarca expulsa a los jóvenes porque hay poco trabajo y algunos se van a estudiar a La Plata o a Buenos Aires.

Según el Programa de Salud Indio Sano, la media en el distrito es de 150 nacimientos por año. Se preguntó si la Maternidad del hospital reuniría las Condiciones Obstétricas Neonatales Esenciales (CONE). Conoció la sala de partos y el lugar de recepción. Le impresionó bien. Las enfermeras eran cálidas y bien formadas. Se habían capacitado por un convenio entre la Municipalidad y la Subsecretaría de Planificación de la Salud, en Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales. Tenía quirófano, cirujano atento, anestesta, todos los medios de reanimación cardiopulmonar y sus experiencias. Banco de Sangre y una unidad móvil de derivación con respirador de emergencia. Clara era la madre y Verónica sería la recién nacida. El binomio había sido controlado por los médicos y por el equipo de salud durante las 38 semanas desde la 6.ª semana del embarazo. Todo bien. Estos obstetras y agentes sanitarios en los domicilios favorecen el control.

La georreferencia, la historia municipal, las normas de atención y la prevención y promoción empezaron a sonarle cotidianas.

La historia, con fichero dinámico excelente. ¡Cómo se aprende participando desde la comunidad! Los partos normales los deben atender los pediatras con competencias adquiridas a lo largo de su formación. Aunque las academias no se enteren por estar tan preocupadas por la enfermedad.

Y por los hospitales. La salud es otra cosa.

El equipo de trabajo con los Consejos Vecinales de Salud del Municipio de Punta Indio (enfermera, agente sanitario, psicóloga, odontóloga, maestra, comunicadora social, obstétrica, educadora sanitaria, médico general) realizó un mapa, región por región, casa por casa, con sus moradores.

Chinches verdes para la normalidad, naranjas para las que tenían algún riesgo concurrente y rojas para las que presentaban riesgo sanitario, educativo, social. El secreto es trabajar participativamente, con lo evitable, promocionable, prevenible.

Las chinches son un “semáforo” necesario para imaginar una salud integral, para imaginar la cultura de la salud por sobre la cultura de la enfermedad.

“La enfermedad hay que ir a buscarla donde vive y donde trabaja la gente”, decía Alberto Alvarado en la década del 60, cuando con sus Agentes Sanitarios erradicó el paludismo en Jujuy y en Salta.

Los equipos hacían “rondas sanitarias” bimensuales y tenían “vigilado” desde lo sanitario todas las familias lugareñas. Obviamente las embarazadas eran un objetivo deseado.

El diagnóstico de embarazo era precoz y los controles adecuados (no menos de 5 en los embarazos normales y 9 en los de riesgo, con las interconsultas y derivaciones normatizadas).

Le presentaron en el Consejo Vecinal de Salud las Condiciones Obstétricas y de Nacimiento en el municipio en el último año.

Camila participó de la Asamblea.

Nunca había tenido, en sus años de facultad y residencia, una tarea con equipos interdisciplinarios y menos con distintos sectores de la comunidad.

### **Problema complejo**

#### **Gestionar, asistir y planificar la salud de los niños de un barrio, pueblo o municipio**

*Reichenbach J. Indio Sano. Una Construcción Comunitaria de la Salud. Buenos Aires: Del Sur; 1997.*

El informe decía que había:

| Eventos                | Total |
|------------------------|-------|
| Nacimientos por año    | 145   |
| 1% menos de 1500 g     | 1     |
| 6% entre 1500 y 2500 g | 9     |
| 7,9% Prematuros        | 12    |

Recordó que en el país en 2011 hubo un total de 83.385 recién nacidos vivos con menos de 1500 g (1%).

Que la sobrevida depende del peso de nacimiento y de la edad de gestación.

Que los de menos de 1500 g, que son solo el 1% del total, contribuyen al 33% de las muertes neonatales.

Que los que pesan entre 1500 y 2.500 g son el 6% del total y contribuyen al 17% de las muertes en el primer mes de vida.

Algo así como “dime cuánto pesas al nacer y te diré si vives”.

Algo así como que hay que evitar por todos los medios posibles que los niños nazcan con menos de 2500 g, ya sea por bajo peso o por prematuridad.

Y que eso se logra en el territorio cuidando adecuadamente a la embarazada. Con una adecuada estrategia de Atención Primaria de la Salud.

Luego analizamos las cifras de distribución de las muertes neonatales según criterios de reducibilidad en la República Argentina, para compararlas con los logros del distrito, en 2011.

**Para ello, Camila leyó la “VENTANA 4. LAS CIFRAS DE LA DEUDA INTERIOR”, del libro *De niños, de anónimos y de esperanzas*, de Juan Reichenbach.**

En nuestro país nacen más de 700.000 niños al año.

Mueren más de 9000 menores de 1 año en ese lapso, algo así como uno por hora.

Más de 20 por día.

Y no salen en ninguna noticia de noticiero vespertino, como aparecen todos y cada uno de los accidentes de fin de semana largo. O los crímenes pasionales.

Las muertes infantiles tienen menos prensa.

La Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) promedia esas muertes en todo nuestro territorio, pero esconde escenarios muy distintos.

Las muertes son reducibles en casi el 60% de los casos en el periodo neonatal, con lo cual estamos afirmando que entre 5 y 6000 muertes de menores de un año son evitables.

Vivir es el primero de los derechos humanos.

Paradójicamente, ni los medios de comunicación, ni las agendas públicas, ni siquiera los organismos de derechos humanos han reparado lo suficiente en estas ecuaciones.

Un ejército de niños recién nacidos y ya muertos en silencio no puede declamar por este elemental principio.

La estrategia de la reducción es EDUCAR PARA EL HORIZONTE DE LA SALUD Y LA EQUIDAD.

Todos los años el 1,1% de los que nacen pesarán menos de 1500 g.

El 6%, menos de 2500 g. El 7,9% serán prematuros.

El 15,6% de sus madres tendrán menos de 20 años.

El 8,8% de sus madres tendrán primaria incompleta.

Obviamente, todos estos factores de riesgo (bajo peso, prematurez, madres adolescentes y analfabetas funcionales, con escasos y tardíos controles del embarazo) no se evitan en los hospitales ni en las salas de parto, donde solo se repara la ineficiencia de las acciones adecuadas de promoción y prevención.

Los escenarios son el hogar, el barrio, el territorio, la escuela, el centro de atención primaria, el club, la iglesia, la unidad básica, el comité, la cooperadora.

En la provincia de Buenos Aires la disminución de la mortalidad infantil ha sido calificada como “histórica”, no obstante lo cual sus autoridades asumen que, para la profundización de la reducción, será necesario el incremento del trabajo intersectorial (involucrando a los sectores de Salud, Desarrollo, Educación y Trabajo), que permita realizar un abordaje integral del niño, la madre y su familia.

### **Cristina, Camila y la promoción de la salud**

Cristina era una militante de la salud. Vivía en una chacra alejada del centro del pueblo, rodeada de eucaliptos, aromos y pinos. Tranquera de acceso, vacas para el ordeño y los quesos caseros. Miel en panales. Gansos, pollos, corderos y azadones. Nidos de horneros, el tordo cantando y la alegría del sol a la mañana alumbrando desde el horizonte interminable.

Camila fue invitada a su casa por el Consejo Local de Salud, que Cristina presidía desde su creación. Entre los mates y el pan casero del horno de barro, se redactó el documento que sigue, destinado a la educación comunitaria de la región. Camila descubrió que la salud era entre todos.

Nunca había imaginado, en la época de facultad y residencias, que los pediatras tenían que escribir para la gente. Para el autocuidado. Para mejorar la salud y no para reparar lo evitable. Esta gente socializaba este “acuerdo interdisciplinario e intersectorial” y lo multiplicaba en las escuelas, en las cooperativas, en los clubes

deportivos, en los centros de jubilados, en la radio local, en los medios escritos y hasta en el Concejo Deliberante, donde tenían una banca honoraria, de opinión sin voto. Una materia que Camila no había rendido: la comunicación social y la salud. Promoción y prevención desde la gente. Y por la gente.

Repasando la semana, Camila concluyó que el Consejo Federal de Salud era su principal guía. Le estaban enseñando a percibir los problemas de las familias y los niños desde la certeza del protagonista real: la gente que asume su derecho a la salud, la madre y el niño como sujetos de derecho. En la escuela aproximadamente la mitad de los alumnos examinados presentaba alguna alteración funcional u orgánica. En ese sistema organizado de salud, el 24% de las consultas eran por controles de crecimiento y desarrollo, de promoción y de prevención. Del total de las consultas, a los menores de un año les correspondía el 60,7%; de 1 a 4 años, el 15,3%; de 5 a 9 años, el 9,02%; y de 10 a 14 años, el 7,9%. En una población de 10.000 habitantes, con una tasa de natalidad de 16 por mil, una Tasa de Mortalidad Infantil de 5,2 por mil nacidos vivos y una Tasa de Mortalidad Materna de 1,6 por diez mil nacidos vivos. Cifras compatibles con los países excelsos de la salud pública.

Tan claro el esquema como que los menores de 1 mes se enferman o mueren por bajo peso, prematuridad, asfixia y malformaciones congénitas. Los niños de entre 1 mes y 1 año padecen infecciones respiratorias agudas, diarrea, trastornos de la nutrición, sepsis y síndrome de muerte súbita del lactante. Luego del año hay que jerarquizar las infecciones respiratorias agudas y las neumonías. El trauma, las lesiones no intencionales, las adicciones, las enfermedades de transmisión sexual en la adolescencia.

Lo más llamativo para Camila fue descubrir que las muertes son reducibles en un porcentaje muy alto (60%) con medidas de salud pública de bajo costo y alto impacto, dependientes más del capital humano que de la estructura. Un alto porcentaje de ellas son reducibles por diagnóstico y tratamiento oportunos. “Reducibles” son las causas cuya frecuencia podría disminuir en función de los conocimientos actuales. Repasa mentalmente la causalidad, que no es casualidad. Otra “lluvia de ideas” la inquieta.

IRAb y bronquiolitis: el 60% de los niños padecen un episodio de IRA antes del año de edad. Solo el 3% se internan. Los lactantes fallecidos por bronquiolitis en el país tuvieron en promedio 3 contactos con el Sistema de Salud. SUH: cerca de 500 casos nuevos por año. Todos evitables. Cardiopatías congénitas: con diagnóstico y tratamiento oportuno sobreviven el 90%.

La neumonía de la comunidad adecuadamente diagnosticada y medicada es de tratamiento ambulatorio. La prematuridad y el bajo peso al nacer se evitan con un control adecuado del embarazo. Una adecuada capacitación en la reanimación del RN en la sala de partos evitaría el 8% de las muertes en la primera semana de vida. El 99% del asma en pediatría es leve-moderado y no requiere internación. La obesidad, los accidentes, las parasitosis, la hipertensión arterial se previenen. El 70% de los niños tienen soplos funcionales. Solo requieren seguimiento CLÍNICO.

## **En la salud**

- Centros de atención primaria

- Consultorios de hospitales
- Consultorios privados
- Maternidades
- Consultorios del niño sano
- Clubes
- Escuelas
- Centros comunitarios.
- CON LA COMUNIDAD

#### **En la enfermedad**

- Salas de Clínica,
- Salas de Emergencia,
- Terapia Intermedia,
- Terapia Intensiva,
- Unidades de Internación neonatológicas,
- Salas y consultorios de especialidades de hospitales.

**Pero con la clínica siempre como protagonista central.**

1. Conceptualizar los hábitats en el proceso de preservación de la salud y adquisición de la enfermedad.
2. Recrear el crecimiento y desarrollo normales.
3. Incluir la concepción de equidad y factores de riesgo con competencias para la promoción y prevención de conductas y hábitos saludables.
4. Conceptualizar la historia clínica como la herramienta fundamental con énfasis en la anamnesis y el examen físico.
5. Normatizar la atención integral de las enfermedades prevalentes priorizando el diagnóstico anticipatorio y precoz, la derivación oportuna y adecuada.
6. Redescubrir la clínica y la epidemiología, el aprendizaje basado en problemas, el trabajo en equipo interdisciplinario y transdisciplinario, con actitud y aptitud para la utilización de los conocimientos adquiridos.
7. Generar hábitos de educación permanente.
8. Enseñar la metodología para el acceso al conocimiento permanente y la metodología de la investigación clínica aplicada.
9. Reconceptualizar la profesión médica desde un sentido ampliado basado en el humanismo, la bioética, la actitud de entrega y servicio.
10. El criterio para abordar estas metas es cronológico.

*En: Programa de Residencias de Clínica Pediátrica de 4 años. Portal de Educación Permanente en Pediatría. Subsecretaría de planificación de la Salud. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires; 2011.*

#### **La extensión y la promoción**

Nunca imaginé tener que escribir para la comunidad. En la revista mensual *Equidad*, que editó la Dirección de Salud de la Municipalidad de La Plata, escribimos con ese objetivo.

En el municipio nacen entre 150 y 200 recién nacidos por año.

Si hacemos la campaña de Promoción y Prevención no tendremos mayores problemas.  
Los controles de cada embarazada están asegurados.  
La Maternidad distrital cumple con las CONE.  
Los embarazos de alto riesgo son derivados oportunamente a los Centros que tienen convenio con el Municipio.

Las cardiopatías congénitas con diagnóstico prenatal también.

**El secreto es la Promoción y la Prevención.**

**El Consejo, los agentes sanitarios, las obstétricas, los ficheros dinámicos y el Sistema del Médico y Enfermeras de Familia con nominalización, fundamentales.**

**Aquí no mueren los RN con muertes evitables.**

En síntesis lo que tengo que hacer es detectar las formas de inicio de las afecciones frecuentes, las prevalentes, como dicen los del Consejo.

Prevenir el RN prematuro y el bajo peso y la muerte súbita del lactante.

Anticipar el diagnóstico de las cardiopatías congénitas.

Evitar la bronquiolitis, promocionar de acuerdo con las evidencias.

Anticipar las neumonías.

Vacunar para evitar las meningitis en las guarderías.

Hablar de la teta.

Del medio ambiente.

Luchar para que los niños no trabajen.

Gestionar agua segura y cloacas.

Alimentación saludable. Control del Crecimiento y desarrollo.

Y la clínica.

Anticipación. Lectura de las familias, de los signos y síntomas guiones.

De la familia y de la madre como nichos integrales.

Acceso, anticipación, igualdad de oportunidades, equidad.

Generar mapas de riesgo sanitario.

Anticipar las enfermedades emergentes de la zona. Colilargos, dengue, botulismo, coqueluche, TBC en los "golondrinas", enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Estar atenta a las corrientes migratorias.

Y pensar en el niño sano, integral, que juega, corre, aprende, no trabaja y vive en una casa y en un medioambiente seguro.

A las guarderías, los jardines y las escuelas. Con el concurso y la sinergia del Consejo Escolar del Municipio. Con la ayuda del vecino y de los agentes sanitarios.

Priorizar la salud escolar y los adolescentes, los olvidados de siempre.

Los que no trabajan, no estudian ni buscan trabajo, que en nuestro país llegan al 20%.

Y las adicciones, y los suicidios y los traumas. Hay que ir a las cooperativas y transformar a los sindicatos, a los profesores de educación física y a los maestros en agentes de salud.

Y los accidentes en la vía pública y en las rutas cercanas. Y la nocturnidad. Las fuerzas de seguridad, los policías y los bomberos son actores protagonistas del hecho sanitario.

Y las ETS. Y el embarazo adolescente Y el aborto clandestino. Y el hijo no deseado.

Y la educación.

**Para mí estos problemas son complejos.**

Están atravesados por una multiplicidad de variables.

De situaciones. Y de nombres.

Claro que, con la nominalización y las familias a cargo, virtualmente se acaban las consultas espontáneas, sin nombre, ni apellido, ni lugar de residencia y dirección, ni seguimiento, como en los consultorios externos o de emergencias de los grandes hospitales.

En estos pueblos pequeños de grandes espíritus las familias y sus hijos tienen nombre, historia única y médico único que desarrolla una atención integral con la direccionalidad del crecimiento y desarrollo, la prevención, el estímulo a las prácticas claves de salud, y el adecuado y oportuno tratamiento de las afecciones prevalentes en la infancia, sin obviar la rápida reparación de las afecciones crónicas o secuelas.

Voy a tener que priorizar el repaso de la historia clínica como herramienta, del Vademécum Municipal y del Laboratorio Municipal Básico, lo que se sintetizará en las Normas Municipales de Tratamiento.

Muchos conceptos nuevos en tan poco tiempo.

Claro que estuve muchos años de mi formación tratando de reparar lo irreparable en la máxima complejidad. Otra historia recién empieza.

### **Salud y enfermedad en la infancia en un municipio de 10.000 habitantes**

Convocamos a Camila a que imaginara los problemas de enfermedad en la infancia que se le presentarían en su desempeño como pediatra de ese municipio de 10.000 habitantes.

Luego de cuentas y revisiones bibliográficas y epidemiológicas, nos entregó este documento situacional en borrador, inicial. Sin duda de gran utilidad para la planificación de la salud de tantos distritos o áreas programáticas de nuestro país. Necesario para evaluar las competencias, habilidades y destrezas requeridas en la formación de grado y en las residencias.

Con el principal de los capitales, el humano, excelso de actitud y de aptitud, empezamos a imaginar la excelencia en la promoción, prevención, asistencia y reparación de las afecciones que inciden en nuestro futuro, nuestros hijos.

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Población total</b>                                 | 10.000 habitantes       |
| <b>Nacimientos vivos registrados (por año)</b>         | 200 por año             |
| 250 nacimientos cada 10.000 habitantes.                |                         |
| Abortos estimados (50 a 75% de los nacimientos)        | 100 a 150 por año       |
| <b>De 10.000 habitantes el 34% es menor de 20 años</b> | 3400 menores de 20 años |



|              |            |      |
|--------------|------------|------|
| DISTRIBUCIÓN | 0 a 5 años | 850. |
|              | 5 a 10     | 850. |
|              | 10 a 15    | 850  |
|              | 15 a 20    | 850. |

### **Afecciones esperables en el recién nacido**

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>1% con peso menor a 1500 g</b>      | 2 por año  |
| <b>6% con peso entre 1500 a 2500 g</b> | 12 por año |
| <b>7,9% prematuros</b>                 | 16 por año |

En una población de 10.000 habitantes.

### **Se derivan oportunamente**

Antes del nacimiento preferiblemente o después del parto a centro de mayor complejidad en UTIN móvil (por convenio municipal), Red Perinatal, con capital humano con competencias requeridas. 45 minutos de la alta complejidad perinatal.

### **Cardiopatías congénitas (8 cada mil de los RN vivos)**

1 nueva cada 5 años en una población de 10.000 habitantes

Preferentemente CIV, CIA, ductus, estenosis aórtica o pulmonar, coartación de aorta y tetralogía de Fallot.

TODAS DE DIAGNÓSTICO ANTENATAL con adecuado control ecográfico de la embarazada.

Se deriva a la embarazada a centro de mayor complejidad en el último trimestre del embarazo.

### **Síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL)**

**1 muerte por SMSL**

**cada 2 años** en una población de 10.000 habitantes

En los primeros 4 meses de vida.

Incidencia nacional 0,4% de los nacimientos.

Realizar promoción y prevención municipal.

Es la 3.ª causa de mortalidad infantil en el primer año de vida en el país.

### **Lesiones no intencionales cada 30 años**

< 1 año (0.03 por año % nacidos vivos) **1 muerte**

Primera causa de muerte

1 a 3 años (0,15% por año nacidos vivos). **1 muerte**

### **cada 6 años**

Entre los 4 y 34 años.

Menos de 1 año por SMSL y sofocación.

1 a 3 años ahogamiento.

Intensa promoción comunitaria.

### **Niños con trastornos del espectro autista (TEA)**

13

nuevos por año.

Incidencia: 68 cada 1000 nacimientos.

Se realiza detección precoz con *screening* antes de los 2 años de vida.

Se deriva a centros específicos PRECOZMENTE.

Se diseña centro multidisciplinario municipal con el apoyo de referentes

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>IRA</b> (60% de los menores de un año por año)<br>nuevos por año<br>Virales la mayoría. Se tratan en el municipio                                                                                                                                                                                 | 120                                   |
| <b>Neumonías</b> (1,25 cada 100 en menores de 5 años)<br>nuevas por año<br>Sin SPP y con control se tratan en el municipio ambulatoriamente.<br>Se interna 1 cada 225 neumonías de la comunidad si el diagnóstico es precoz 1 se interna                                                             | 20                                    |
| <b>Bronquiolitis aguda</b> (0, 20 a 2, 8 muertos cada 1000 nacidos vivos)<br>cada 5 años.<br>Hasta 80 casos en primer año de vida (40%).<br><b>Se internan 3% en el año. Se derivan oportunamente 3 por año.</b>                                                                                     | 1 muerte<br><br><br><b>Menos de 3</b> |
| <b>Infección urinaria en lactantes febriles (7%)</b><br>nuevas por año                                                                                                                                                                                                                               | 30                                    |
| <b>Obesos</b> (30% de la población menor de 20 años). Exógenos<br><b>obesos en total.</b><br><b>Hay 1 obeso endógeno cada 200 exógenos (4,5 de 900).</b><br>Intensa promoción y prevención.<br>Alimentación segura.<br>Control en CAPS y domicilios.<br>Escuelas saludables.<br>Deporte y recreación | 900                                   |
| <b>Hipertensión arterial (30% de los obesos)</b><br><b>subdiagnosticados.</b><br><i>Screening</i> masivo.<br>En la escuela, en el club y en la plaza.<br>Programas de extensión y control poblacional e individual.                                                                                  | <b>270 hipertensos idiopáticos</b>    |
| <b>Enfermedad celíaca (1%)</b><br>municipio.                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 en el                              |
| <b>Mal descenso testicular (8% de los RN)</b><br>nuevos por año.<br>En el primer año desciende el 50%. Se derivan 8 cirugías por año                                                                                                                                                                 | 16                                    |

|                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Retraso del habla y del lenguaje (5% de los niños desde los 2 años por año.</b>      | <b>10 nuevos</b> |
| Formar equipo interdisciplinario municipal.                                             |                  |
| <b>Enfermedades raras (1 cada 2000 habitantes el municipio</b>                          | <b>5 en</b>      |
| Se derivan a Centro de Referencia                                                       |                  |
| <b>Fisura labio alveolo palatina. (1 cada 1000 habitantes) municipio</b>                | <b>10 en el</b>  |
| Se derivan a Centro de Referencia.                                                      |                  |
| <b>Discapacitados (12,9 de toda la población) 1.290</b>                                 |                  |
| Se desarrolla centro municipal con asesoría.                                            |                  |
| <b>Inmunodeficiencias primarias (2 cada 10.000 habitantes) 2</b>                        |                  |
| Alto índice de sospecha clínica                                                         |                  |
| <b>Síndrome de Down (0,15 de los RN vivos) 3 a 4 años</b>                               | <b>1 cada</b>    |
| <b>Incesto (variable) (2 cada 10.000 habitantes, por año) 2 por año.</b>                |                  |
| Intenso trabajo comunitario, intersectorial, multidisciplinario, cultural, comunitario. |                  |
| <b>Enfermedades poco frecuentes o raras (1 caso cada 2000 habitantes) 5 en total</b>    |                  |

## **Bibliografía**

Argentina. Ministerio de Salud. *Plan Estratégico para la Reducción de la Mortalidad Materna y la Mortalidad Infantil*. Buenos Aires: Ministerio de Salud; 2009.

Argentina. Ministerio de Salud. *Plan Operativo para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de las Mujeres y de las Adolescentes* [en línea]. Buenos Aires: Ministerio de Salud; 2010 [acceso 10 ago. 2017]. Disponible en: [http://www.msal.gob.ar/plan-reduccion-mortalidad/pdfs/plan\\_operativo\\_reimpresion\\_junio2010\\_WEB.pdf](http://www.msal.gob.ar/plan-reduccion-mortalidad/pdfs/plan_operativo_reimpresion_junio2010_WEB.pdf)

Colabianchi L, Reichenbach J. *Indio Sano; una construcción comunitaria de la salud*. Buenos Aires: Del Sur; 1997.

*De niños, de anónimos y de esperanzas* [Página principal en Internet]. 2011. [actualizada en ago. 2017; acceso 11 ago. 2017]. Disponible en: <https://es-es.facebook.com/.../De-niños-de-anó-nimos-y-de-esperanzas/>

Declaración de interés legislativo del libro *De niños, de anónimos y de esperanzas*, del Dr. Juan Reichenbach. Expediente: F 180 2014-2015. Cámara de Senadores.

Kliksberg B, Sen A. *Primero la Gente*. Barcelona: Deusto; 2008.

Kliksberg B. *Los parias de la tierra. Entre la miseria y la xenofobia*. Buenos Aires: La Página; 2014.

Portal de educación permanente en pediatría [Página principal en Internet]. 2017. [actualizada en ago. 2017; acceso 11 ago. 2017]. Disponible en: [www.ms.gba.gov.ar/.../pediatria/portal-de-educacion-permanente-en-pediatria](http://www.ms.gba.gov.ar/.../pediatria/portal-de-educacion-permanente-en-pediatria)

“Programa de Residencias de Clínica Pediátrica de 4 años”. En: Portal de educación permanente en pediatría [Página principal en Internet]. 2017. [actualizada en ago. 2017; acceso 11 ago. 2017]. Disponible en: <http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/pediatria/>

Reichenbach J et al. *Selección de Residentes: construcción futura de la salud*. La Plata: Ministerio de Salud; 2011.

Reichenbach J, Fontana S, Gómez W. *Pediatría en Red*. La Plata: Ministerio de Salud; 2015.

Reichenbach J. *Criterios Diagnósticos en Clínica Pediátrica. Tomo 4*. Buenos Aires: Del Sur; 1997.

Reichenbach J. *Mamasana: el ABC del niño y la madre*. Publicación de la Secretaría de Salud y Medicina Social de la Municipalidad de La Plata 2011; 1,2 y 3.

Reichenbach J. “Un Pediatra deseable”. En: *De niños, de anónimos y de esperanzas*. La Plata: Pro-infancia; 2013.

*Revista Equidad en salud Infantil*. La Plata: Municipalidad de La Plata; 2012.

SAP, UNICEF. *Salud Materno-Infanto-Juvenil en cifras 2013* [en línea]. Buenos Aires: SAP; 2013 [acceso 10 ago. 2017]. Disponible en: [https://www.unicef.org/argentina/spanish/salud\\_SapUnicef\\_cifras2013.pdf](https://www.unicef.org/argentina/spanish/salud_SapUnicef_cifras2013.pdf)

